“银发族”健康短视频使用的现实困境与纾解路径

邓婷月

摘　要　社交媒体语境下，短视频作为健康传播的新兴媒介，逐渐成为老年群体获取健康信息的主要渠道。研究以知信行理论为支撑，从老年群体对健康短视频的接触和使用现状出发，针对老年群体在信息接触、鉴别与解码上的三重困境，分析其内在生成逻辑，并从认知、信念、行为三个维度提出相应的传播策略和发展建议，旨在提高老年群体的健康水准和生活质量，助力健康中国建设。

关键词　银发族；数字鸿沟；健康短视频；知信行理论；信息偶遇；代际反哺

中图分类号　G2　　**文献标识码**　A　　**文章编号**　2096-0360（2024）02-0015-04

DOI:10.16604/j.cnki.issn2096-0360.2024.02.022

在社交媒体环境中，短视频凭借其独有的视听优势，拓展了银发族接受健康知识的空间和形式，为健康传播实践构建了一个新的内容生态圈。然而，短视频平台的去中心化特性使得健康传播语境由高话语模态转向低话语模态，导致健康信息的权威性和专业性逐渐被消解，从而形成了有效知识与虚假信息并存的喧哗迷局。在此背景下，银发族在短视频平台中的健康传播实践面临哪些挑战？表层困境的背后隐藏怎样的深层机制？存在怎样的纾解路径？这些是本论文亟待解决的重点。

1　无形之墙：“银发族”健康短视频使用的现实困境

社交媒体的低语境化为健康传播纳入多元主体的同时，也为“伪专家”和“伪健康”的自我营销提供了便利的环境条件，更为健康信息的传播增添了极大的不确定性，引发了老年群体在信息接触、鉴别以及解码方面的三重困境。

1.1　被动入场：信息接触以“偶遇”为主

信息偶遇是指信息使用者并非因为特定意图或目的进行主动搜寻的意外的信息获取现象[1]，这一概念在老年人使用健康短视频的境况尤为适用。老年化的过程往往伴随着对身体控制能力的丧失，随着时间的流逝，老年人的视力和记忆力都出现不同程度的下降，导致他们的学习能力降低，往往没有足够的能力在短视频平台有效地搜寻健康信息。身体的衰老和文化适应能力的滞后限制了他们追求更高层次的媒介活动，也削弱了短视频的多功能属性。因此，大多数老年人只能被动地接收信息，困于算法推荐形成的健康“信息泡泡”。此外，由于缺乏对新技术的接纳能力，老年人普遍存在着信息检索障碍，在获取健康信息时更倾向于依赖算法，使“偶遇”成为他们在媒介化社会中的生存境况。因此，他们更偏向短视频平台的“信息找人”而非“人找信息”的信息推送特征，简单的“往上刷”操作更符合他们被动的行为特性及浏览需求[2]。在这个过程中，老年人主动搜索健康信息的意愿大大降低，“偶然”遇见信息成为他们健康传播实践的常态。

1.2　信念固化：信息鉴别遵从经验之谈

在充斥着多样性以及不确定性的现代社会中，人们只能被迫地选择和信任，进而独自承担这种选择带来的后果[3]。作为健康信息的主体受众，老年人往往有着更高的健康需求，却容易因健康短视频质量的参差不齐陷入信息辨识困境。由于生活环境的影响，老年人在长期的生活经验中形成了一套固定的观念体系和行为习惯，他们的健康信念并未随着新媒介技术的发展而更新。面对短视频中海量的健康信息，他们感到无所适从，只能依赖固有的健康信念来判断信息的真伪。在老年人的信念图景中，“专家”拥有传播知识的绝对权威，因此，当许多以“医生”“专业人士”自居的“伪专家”通过短视频平台传播各类伪健康信息时，他们往往主动或被迫地相信，无意中成为伪健康信息传播的“中转

基金项目：国家社科基金一般项目“县级融媒体创新基层社会治理的现实基础与拓展路径研究”（项目编号：20BXW039）。

作者简介：邓婷月，湖南师范大学，研究方向为老年人健康传播。

站”和“推动者”。与此同时，健康信念的因循守旧使他们在面临健康问题时更相信经验之谈，于是，当“独门配方”“祖传秘籍”等字眼出现在健康短视频的话题标签或封面标题中时，很容易激发他们的信任，使得伪健康信息的“数字化野火”不断蔓延。

1.3 认知偏差：信息解码存在意义曲解

信息解码即接收者以自己的知识经验对信息进行分析和理解的过程，旨在揭示信息的真实含义和意义。理想的信息解码能最大限度地避免接收者因认知偏差而造成对原信息内容的意义曲解[4]，然而，由于生理和心理的双重影响，老年人在解读健康短视频时极易产生偏差和误解。一方面，记忆力的下降和注意力的分散使老年人的认知负荷严重不足，难以准确理解和评估健康信息的价值和有效性。同时，身体各项机能的衰退使他们只能在短视频中“偶遇”健康信息，信息来源的单一逐渐窄化知识视野，让他们易受到片面或错误知识的干扰。另一方面，社会心理学研究显示，人类是认知吝啬者[5]，更倾向于依赖直觉等认知捷径来处理信息，以减少认知过程中所需花费的精力[6]。由于媒介素养与健康素养的双重低下，大多数老年人缺乏主动的信息辨知，从心理层面来看，他们更愿意相信与其自身健康观念一致的信息，对于与自身健康观念不一致的内容进行信息回避，以保持认知的协调状态[7]，缓解健康焦虑心理，最终导致他们对健康短视频内容的意义曲解。

2 生成机制：“银发族”健康短视频使用困境之内在逻辑

短视频通过其可视化和互动性特性为老年健康传播加速助力的同时，也带给银发族更多的认知挑战和使用风险。作为健康传播生态中的“信息人”，银发族的健康信息接收会受到更深层因素的影响，从而改变自身的态度和行为。

2.1 算法规训与圈层审视下的信息壁垒

算法推荐通过信息分发的协同过滤，依据老年人的阅读偏好和浏览记录进行同类推荐，为其营造个性化的健康信息场域，这种看似融洽的传受关系，实则掩盖了算法背后的权力规训对于个体自由的剥夺。当健康信息被有选择性地分发给老年用户时，他们极易因个体的浏览差异与信息偏向陷入“信息茧房”，进而产生认知的“回声室”效应。此时，受算法高度控制的老年群体陷入一种虚假认知，他们认为自己不想看可以随时划走，拥有高度的选择自由，但恰恰是这种看似高度的“自由”与“控制”感[8]，让老年群体成为健康信息接收的被动终端而不自知。此外，社交媒体的发展也伴随着网络圈层的形成。在层级化的网络结构中，老年群体仍然处于边缘位置。尽管健康短视频的主要受众是老年群体，但其视频内容与话语表达往往偏向年轻化，缺乏适老化的话语改造。由此，当某些健康短视频以年轻化的“流行用词”来解释健康知识时，极易导致素养匮乏的老年用户产生认知偏差，这本质上是年轻网络圈层对老年网络圈层的审视[9]。圈层文化的隔阂导致老年群体圈地自困，陷入逐渐固化的认知视野，筑就无意识的健康信息壁垒。

2.2 数字鸿沟与代际反哺的双重阻抗

新时代数字技术主动且强硬地“闯”入人们的日常生活，老年人逐渐沦为边缘群体，与年轻世代的“数字鸿沟”进一步加剧。这种数字鸿沟已不再是简单的老年人自行审度后对于现代数字化生活方式的主动选择，而是老年人在社交媒体时代被迫接受并适应现代数字化生活方式所产生的错位与矛盾[10]。在这种错位与矛盾的影响下，老年人只能被动地感受对新媒体文化的迷茫与隔阂，在信息资源的获取和有效识别上处于弱势地位，通常难以完全凭借自身力量实现信息化适应。

家庭作为老年人信息接收的基本单元，是数字反哺和健康传播的重要场域。然而，由于生长环境和文化程度的差异性，代际双方的交流互动必然伴随着不同观念的博弈，沟通壁垒使反哺仅仅停留于短视频App的下载以及使用基本操作等层面的简单技能反哺，而无法深入到对于健康信息有效性和真实性辨识等较高层面的素养反哺，难以改变老年群体“所见即真实”这一根深蒂固的健康信念。再者，代际反哺作为老年群体“再社会化”的过程，路途漫长而极具挑战。传统担任“学习者”角色的子代转变为“教育者”，而亲代的角色则转变为“跟随人”[11]，家庭结构中话语权威的转向使得健康反哺中的代际矛盾不断，新旧信念的冲突进一步加剧代际隔阂，双方作为曾经和现在的教育者，都想占据沟通的主导权，使得信息的交流演化为情绪的辩解，难以达到转变老年人健康信念的预期。

2.3 角色落差感知下健康行为的主体性缺失

老年在一定程度上意味着自我角色的迁徙与再造[12]。从过去的劳动者到如今的退休者，从家庭中的权威者到跟随者，从主体角色到依赖角色，老年人在社会和家庭中的角色地位都发生了巨大变迁。巨大的角色落差使得老年人逐渐丧失了在社交媒体环境中的话语主动权，健康主体性也逐渐呈现出“缺位”的状态[13]。因而尽管健康“自我负责”是社会的主流叙事，但老年人因为种种原因进入“健康依赖他人”模式[13]，其健康需求和保障越来越依赖他

者的支持。一方面，社会角色的边缘化加剧了老年人的信息落差，让他们在网络话语场中整体呈现出“失声”状态；同时，高使用门槛的短视频平台也给他们带来了信息检索障碍，让他们成为健康信息的被动接收终端，形成算法依赖，健康行为实践的主动性大大降低。另一方面，伴随着退休与之而来的孤独感与角色转变落差导致的低自我效能感，让老年人处于健康信息获取的消极状态。这时，亲友和朋辈充当其健康认知图景中的“重要他者”，源自家庭的安全感和源自朋辈群体的归属感使老年人形成代际依赖和同辈依赖，极大地削弱了自身健康行为的主体性。

3 破壁之道：银发族健康短视频使用的纾解路径

英国学者柯斯特提出了健康传播的知信行理论，将人们的健康传播实践分为获取知识、产生信念、行为改变三个环节，认为知识是行为改变的基础，信念和态度是行为改变的驱动力[14]。该理论不仅能够解释老年群体健康传播活动中所面临的基本问题，而且为解决老年群体使用健康类的短视频所面临的现实困境提供了策略支撑。

3.1 平台赋权：多样化信息满足突破认知壁垒

健康传播的核心在于健康知识的传播，信息传递作为“知—信—行”传播过程的首要环节，主要作用于用户的健康认知系统。短视频平台作为老年人获取健康信息的主要渠道，首先，在内容生产层面应注意编码的灵活性，可以通过3D动画或视频的动态化演示，结合文字、声音、图像等形态丰富的多模态符号，让健康信息的传递具有更强的可视化特性，并在话语表达上进行相应的适老化改造，减少流行用词和专业术语的使用，确保内容清晰而高效地传递，以最大程度地减少专业知识壁垒与老年人的认知偏差，增强“不确定性”背后的“确定性”。其次，基于老年群体的健康信息壁垒，平台应当主动“破壁”，加强人工干预，优化算法推荐技术，让算法摆脱“偏食”的问题，为老年用户提供多样化的健康“信息泡泡”，定期更新老年人的健康认知。最后，针对老年用户存在的操作困难，平台应推出极简化的信息检索页面，提供语音搜索的便利，以尽可能降低老年用户主动搜索健康信息的难度，形成知识传递的良好内容生态，实现健康传播的大格局。

3.2 青银共建：以情感为纽带引领健康信念

在后喻文化时代，数字反哺成为弥合老年鸿沟的有效途径。其中，家庭是关键一环。子代作为“数字原住民”，是伴随着数字化和媒介化成长的一辈，他们有着较高的文化素养和媒介素养，是老年世代新媒体健康传播实践中不可或缺的“引路人”。然而，新旧观念的碰撞与子代话语的权威转向极易引发亲代的情绪对抗，阻碍数字反哺的有效进行与代际关系的改善。因此，子代在反哺过程中应克服工具性的反哺偏向，更注重老年人隐藏在健康需求之下的情感需求。在技术反哺上，子代应充分利用数字赋权，帮助亲代学习使用短视频工具，并亲身演示具体操作，对他们的信息检索难题给予有效指导和积极干预，关注他们的心理变化，以耐心消解亲代的技术恐慌。在信息反哺上，子代应充分考虑到代际健康信念的差异，协调交流中高低语境的不对等，以简单明确的语言教授他们辨识健康信息的技巧，最大限度地减少代际反哺的沟通壁垒，潜移默化地提高亲代的健康素养。同时，基于代际双方引导角色的互换，子代应抚慰亲代产生的抵抗和反叛情绪，转变对话模式，以平等交流的姿态让亲代接受新观念的碰撞与洗礼，引导他们的健康信念与时俱进，以激发其健康行为动机，促进健康反哺的深化。

3.3 自我赋能：化“被动”为“主动”增强健康行为主体性

健康行为达成是“知信行”传播的最终环节，也是衡量健康传播效果的重要指标。在健康传播实践中，老年人的自我效能感是决定其是否实现行为转变的关键因素，却因角色落差所带来的话语权旁落和数字融入困境大大降低。作为时代变迁的亲历者与奉献者，每一个老年人都渴望享受数字化技术带来的便利。尽管角色落差的客观现实无法改变，但老年群体能够通过数字反哺的学习克服知识和技术鸿沟的阻碍，自我赋能让自己不再“失语”。老年人应主动突破心理障碍，积极搜寻符合其个性化需求的健康信息，根据自身的健康状况及时通过点赞、评论等方式给予信息反馈，把握自身在社交媒体中的话语权，建立稳定的自我效能感，从而逐步提高健康行为的主动性。此外，由平台赋权所带来的信息补偿和代际反哺的信念引领转化为老年人的行为动机，有利于促成他们的健康行为转变。老年人应基于正确的健康认知和健康信念改变不当的健康习惯，根据自身的健康状况合理调整健康行为，促进个体身心的全面健康，提高自身健康传播实践行为的主动性和主体性。

4 结语

银发族作为一个特殊群体，在中国的传统文化

语境中，被赋予了许多既定的态度与观念。在这个新事物层出不穷的时代，“老”似乎被置于了时代的对立面，生理机能的衰退和社会角色的变迁使得老年人在新媒介环境中显得格格不入。在健康传播视域下，短视频作为新兴媒介，由于其可视化与互动性特质，为老年群体获取健康信息带来了优质体验，但同时也加重了他们的健康认知负担，削弱了他们健康行为的主体性。老年人作为社会媒介化中的边缘和弱势群体，其健康需求的满足更依赖社会和他者的支持。由此，在以短视频为主要渠道的健康传播实践中，应充分考虑老年群体的弱势地位和个性化健康需求，多方共同发力，引导老年人建立正确的健康认知和信念，促使其健康行为的转变，助力健康中国建设。

参考文献

[1] ERDELEZ S.Information Encountering: It's More Than Just Bumping into Information[J].Bulletin of the American Society for Information Science and Technology，1999（3）：25.

[2] 宋楚慧，吴越，唐雨筠，等.基于新媒体的老年群体健康传播与代际沟通研究[J].新媒体研究，2022，8（9）：35-39.

[3] 魏智慧，尚新童.资本获取与重构：退休老年人群的短视频应用[J].视听，2022（11）：142-145.

[4] 喻国明，颜世健.认知竞争时代的传播转向与操作策略[J].东南学术，2022（6）：227-237，248.

[5] STANOVICH K E.Metarepresentation and the great cognitive divide: A commentary on Henriques' “Psychology Defined” [J].Journal of clinical psychology，2004，60（12）：1263-1266.

[6] 何艺璇，闫文捷.谁在社交媒体扩散虚假健康信息？——健康素养与分析性思维的作用[J].新闻记者，2021（7）：72-85.

[7] 公文，欧阳霞.认知偏向与传播困境：老年人代际健康信息传播研究[J].西南民族大学学报（人文社会科学版），2021，42（6）：192-198.

[8] 熊皇，梁亦昆.与信息偶遇：媒介化社会中乡村老年群体的在线健康信息获取行为研究[J].现代传播-中国传媒大学学报，2022，44（12）：38-47.

[9] 陈静，李月.缺席与在场：老年人群体网络传播路径新探[J].北方传媒研究，2021（6）：92-96.

[10] 于潇，刘澍.老年人数字鸿沟与家庭支持：基于2018年中国家庭追踪调查的研究[J].吉林大学社会科学学报，2021，61（6）：67-82，231-232.

[11] 王敏芝，李怡萱.数字反哺与反哺阻抗：家庭代际互动中的新媒体使用[J].广州大学学报（社会科学版），2022，21（1）：77-90.

[12] 庄曦.城市老年群体微信健康信息的接触与鉴别研究[J].南京师大学报（社会科学版），2019（6）：112-122.

[13] 曹博林.“失声的主角”：新冠疫情下中老年人的防疫行为逻辑与风险应对策略[J].学术研究，2022（2）：59-66.

[14] RESENSTOCK I M.Historical origins of the health belief model[J].Health Education Monographs，1974（2）：328-335.

↑↑（上接第14页）↑↑

家网站数据分析[J].中国文学批评，2021（3）：141-149，160.

[10] 郭庆光.传播学教程[M].北京：中国人民大学出版社，2011：168.

[11] 许苗苗.“网文”诞生：数据的权力与突围[J].探索与争鸣，2021（10）：169-176，180-181.

[12] 崔宰溶.中国网络文学研究的困境与突破[D].北京：北京大学，2011.

[13] 尼克·斯尔尼塞克.平台资本主义[M].程水英，译.广州：广东人民出版社，2018：51.

[14] 李普曼.公众舆论[M].阎克文，江红，译.上海：上海人民出版社，2006.

[15] 张允，姚玉娇.“互联网+”时代网络IP剧的传播研究[J].现代传播-中国传媒大学学报，2016，38（6）：85-89.

[16] 黎杨全，李璐.网络小说的快感生产：“爽点”“代入感”与文学的新变[J].海南大学学报（人文社会科学版），2016，34（3）：81-88.

[17] 汤姆·斯丹迪奇.社交媒体简史：从莎草纸到互联网[M].林华，译.北京：中信出版集团，2019：22.

[18] 彭兰.新媒体用户研究[M].北京：中国人民大学出版社，2020：243.

[19] 许苗苗.两种穿越的讲法：跨次元现实与新媒介时代的现实主义[J].南京社会科学，2023（7）：133-141.

[20] 邵燕君.传统文学生产机制的危机和新型机制的生成[J].文艺争鸣，2009（12）：12-22.

[21] 风笑天，孙龙.虚拟社会化与青年的角色认同危机：对21世纪青年工作和青年研究的挑战[J].青年研究，1999（12）：15-19.

[22] 喻国明，滕文强.元宇宙：构建媒介发展的未来参照系：基于补偿性媒介理论的分析[J].未来传播，2022，29（1）：2-9，128.